

P 氣切套管抽吸

- (一)預先給氧：依病人狀況給予適當氧氣，使用 SpO₂ 持續監測。
- (二)抽吸壓力：將抽吸壓力錶調整至適當的壓力（成人 120~150 mmHg，小孩 100~120mmHg，嬰幼兒 80 ~ 100 mmHg），避免壓力過大，造成黏膜損傷。
- (三)選擇尺寸：選擇抽吸管尺寸，以不超過氣切口徑及鼻口徑的 2/3 為原則（成人使用 12-14 號尺寸）。
- (四)連接機器：打開抽痰管之包裝（先不要抽出），將接頭接在抽吸器的橡皮管上。
- (五)無菌技術：戴上無菌手套，將抽痰管抽出，注意勿讓抽痰管碰觸周遭物品，以保持無菌。
- (六)套管深入：打開機器開關，將抽痰管輕柔放入氣切口（註 1）。插入深度-氣管內管：20~30 公分；氣切管：深入到底後再回抽約 1~2 公分。此時不按壓控制孔。
- (七)回抽控制：慣用手的食指和拇指將抽吸管以旋轉 360 度方式，輕柔

快速地將抽痰管緩緩回抽，非慣用手控制抽痰管上的控制孔，使產生間歇抽吸壓力（一次抽吸時間不超過 15 秒，註 2）。

(八)**再次評估**：抽吸完畢給予病人氧氣，如需再抽痰，應間隔 1-2 分鐘，並觀察病人反應，避免缺氧及黏膜損傷。

(九)**清潔套管**：抽痰結束後將抽痰管放入清水罐內，抽吸清水沖洗管路（註 3）。

(十)**包裹丟棄**：將使用後之抽痰管以打圈方式纏繞於戴抽痰手套的手上，以手套外翻方式包裹抽吸管後，丟棄至感染性垃圾收集袋。

註 1：若病人有氣切造口，必須先抽吸氣切套管再抽鼻、口，不可用抽鼻腔或口腔的抽痰管來抽吸氣切，避免交叉感染。抽吸順序：氣切口-->鼻腔-->口腔。

註 2：抽吸中若病人發生劇烈咳嗽，應立刻抽出抽痰管（避免抽吸時與病人呼吸產生對抗，增加胸腔內壓力，妨礙心臟的循環）。

註 3：抽痰管經清水沖洗後，勿重覆使用；抽痰手套亦同。